



惊恐发作和惊恐障碍

作者: [John W. Barnhill, MD, New York-Presbyterian Hospital](#)

Reviewed By [Mark Zimmerman, MD, South County Psychiatry](#)

已审核/已修订 8月 2023 | 修改的 1月 2026

惊恐发作是一段短暂的极度痛苦、焦虑或恐惧，突然开始并伴有躯体和/或情绪症状。惊恐障碍涉及反复的惊恐发作，导致对未来发作的过度担忧和/或为了回避可能触发发作而做出的行为改变。

- 惊恐发作导致的躯体症状包括胸痛、憋闷、头晕、恶心和气短等。
- 本病的诊断依据包括患者对惊恐发作的描述和对未来发作的恐惧。
- 治疗方法包括抗抑郁药物、抗焦虑药、暴露治疗和心理治疗。

惊恐发作比较常见，每年均有 11% 以上的成年人出现惊恐发作。绝大多数人不需要治疗就可以从惊恐发作中自然恢复；部分可发展为惊恐障碍。

惊恐发作可能会作为任何[焦虑障碍](#)的一部分而发生。惊恐发作也可能发生在其他精神健康疾病患者中（如[抑郁症](#)）。一些惊恐发作会在特定情境下发生。例如对蛇恐惧的患者在遭遇蛇时可以出现惊恐发作。其他发作则没有任何明显触发因素。

惊恐障碍指人们担忧他们会有更多的惊恐发作，和/或为了避免发作而改变他们的行为。惊恐障碍每年出现在 2% 至 3% 的人群中。就惊恐发作和惊恐障碍的发生率而言，女性是男性的 2 倍。惊恐障碍通常始于青春期晚期或成年早期（参见[儿童和青少年的惊恐障碍](#)）。

惊恐发作和惊恐障碍的症状

惊恐发作包括突然出现强烈恐惧或不适，以及以下躯体和精神症状中的至少 4 项：

- 胸部疼痛或不适
- 窒息的感觉
- 眩晕、步态不稳或晕厥
- 害怕死亡
- 害怕发病或失控
- 非真实感、对环境陌生或隔离感

- 发热或寒战
- 恶心、胃痛或腹泻
- 麻木或针刺感
- 心悸或心动过速
- 呼吸急促或窒息感
- 出汗
- 震颤或发抖

您知道吗.....

- 虽然惊恐发作会引起呼吸短促或胸痛等症状，但它们并不危险。

由于惊恐发作症状涉及许多类型的躯体症状，患者经常担心自己患有心脏、肺或脑等方面的严重疾病。例如，惊恐发作期间可能发生胸痛，而人们可能会担心自己有心脏病发作。重度或持续性症状应由医生进行评估。然而，患者可能会多次就医或看急诊科，直到作出正确的惊恐发作诊断。

虽然惊恐发作会导致不适——有时是极度不适——但并不危险。症状通常在 10 分钟内达到顶峰，并在几分钟内消失，因此医生可能无法直接观察到症状。

由于惊恐发作的原因可能不明确，患者可能经常猜测和担心下一次发作——这被称为预期性焦虑——而尽量回避那些与既往惊恐发作关联起来的情境。

它的发作频率也千差万别。一些人可能每周甚至每天均有发作并持续数月，而另一些人则是发作数天后数周或数月未再发。

惊恐障碍通常伴有至少一种其他疾病。其他焦虑障碍、重度抑郁、双相障碍和轻度酒精使用障碍是最常见的并存精神健康疾病。常见的并存疾病包括异常心律、甲状腺功能亢进、哮喘和慢性阻塞性肺疾病 (COPD)。

惊恐发作和惊恐障碍的诊断

- 医生根据标准精神病诊断标准进行评估

因为严重的躯体疾病往往会导致一些和惊恐发作相同的躯体和精神症状，医生首先确保患者没有躯体疾病。医生会收集有关患者发作经历的信息，并可能会针对其他问题进行检查。

惊恐障碍的诊断依据是患者反复出现无诱因的和不能预料的惊恐发作，而且伴随持续一个月以上出现以下表现：

- 持续担心会有更多的惊恐发作或担心发作的后果（例如，他们会失去控制或发疯）
- 由惊恐发作引起的行为变化（例如，避免可能导致发作的情境）

一旦医生确定患者的症状是由惊恐障碍引起，他们在未来惊恐发作时尽量避免进行过多检查，除非患者的症状或体格检查的结果提示新的问题。

惊恐发作和惊恐障碍的治疗

- 抗抑郁药和/或抗焦虑药
- 心理治疗，包括暴露疗法、认知行为治疗和人际关系心理治疗

在没有正规治疗的情况下，一些患者能够康复，尤其是如果他们继续面对带来发作的情境。对于其他患者，症状会反反复复多年。

但是，如果患者经常发作并改变了他们的行为以避免未来发作，通常需要使用药物治疗和/或心理治疗。如果惊恐障碍患者理解本病的病因包括生理和心理两方面，以及治疗通常能够控制症状，那么他们会更容易接受治疗。

药物

治疗惊恐障碍的药物包括

- 抗抑郁药
- 抗焦虑药物，如苯二氮卓类药物

绝大多数抗抑郁剂——三环类抗抑郁剂 (TCA)、单胺氧化酶抑制剂 (MAOI)、选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂 (SSRI) 和 5-羟色胺-去甲肾上腺素再摄取抑制剂 (SNRI) ——是有效的（参见表格[用于治疗抑郁症的药物](#)）。

相较于抗抑郁药物，苯二氮卓类起效更快但可引起[药物依赖](#)并容易引起嗜睡、协调性损害、记忆问题和反应时间减慢。

SSRI 或 SNRI 与其他药物相比治疗效果相似但不良作用少，故常作为首选治疗药物。例如，尽管大多数 SSRI 和 SNRI 骤然停药会导致不适的戒断症状（例如，头晕、疲劳、头痛、恶心），但很少引起嗜睡，也不会引起药物依赖。

初始治疗时，患者可使用一种苯二氮卓类药物和一种抗抑郁药。当抗抑郁药开始发挥作用时，可逐渐降低苯二氮卓类药物剂量，直至停用。但是，对于一些人来说，苯二氮卓是唯一有效的长期治疗。

药物可预防或大幅减少惊恐发作次数。但是，如果没有心理治疗，药物可能不会帮助患者减少对未来发作的担忧，并停止回避引起惊恐发作的情境。

因为惊恐发作常在停药后复发，故药物治疗的周期较长。

心理治疗

大多数针对焦虑障碍（包括惊恐障碍）的心理治疗会教授促进放松的技巧。放松策略包括正念、冥想、催眠、锻炼和缓慢、稳定的呼吸。这些策略是治疗的重要组成部分，因为它们既可以减轻焦虑，又可以继续进行可能引起焦虑的心理治疗。

认知行为治疗 (CBT) 已证明对惊恐障碍有效。CBT 是一个用于描述各种侧重于功能失调思维和/或功能失调行为的谈话疗法的术语。

患者可能有自己独特的但功能失调的思维循环，这可以诱发焦虑和/或惊恐。例如，一个人可能会对心脏病发作有基线担忧，并花过多时间扫描身体以寻找心脏病发作的迹象。如果他们感到胸部有刺痛，他们可能会开始一个快速引起惊恐的思维循环，误认为他们即将死亡。CBT 涉及阐明这些循环，然后教导患者意识到并控制他们扭曲的思维和错误信念。然后，他们能够更好地改变自己的行为，使其更具适应性。此外，治疗鼓励他们逐渐暴露在可能引起惊恐的情境中，从而降低他们对环境和症状之间关系的敏感性。

可能教导患者以下几点：

- 不要试图逃避那些诱发惊恐发作的情景或因素
- 意识到他们的恐惧不太可能导致不良后果
- 当惊恐发作可尝试用浅慢呼吸或其他的方法使自己放松

了解更多信息

以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。

[国家精神卫生研究所，惊恐障碍](#)：惊恐障碍各方面的一般信息，包括危机热线和教育计划